



3

53. ÅRGANG | 03 • 2016

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Indhold

Motiverende mobilteknologi i skole-hjemsamarbejdet – betydning og implementering

Inklusion – en proces på mangfoldige niveauer

Skriv med glæde – få mere lystbetonede og fleksible skriveprocesser

At styrke forbindelser – Evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Danske elevers opfattelse af fredsundervisning

Indretning af daginstitutioner som bo-grupper

Hvordan kan der skabes motivation og trivsel hos udsatte unge gennem træning af resiliens?

Debatindlæg: Er ADHD, en neurologisk forstyrrelse, en sosial konstruksjon eller kan det være både-og?

PPR og skolens samarbejde med forældrene

Mindeord for Anders Poulsen

Hvordan kan der skabes motivation og trivsel hos udsatte unge gennem træning af resiliens?



I artiklen præsenteres teoribaseret ResiliensTræningsProgram, RTP, der er målrettet unge mennesker i mistrivsel. ResiliensTræningsprogrammet er forankret i metoder og teorier inden for positiv psykologi, kognitiv adfærdsterapi, relationer, positive emotioner, mindfulness og motivation. ResiliensTræningsprogrammet består af syv lektioner af ca. 45 minutters varighed med en uges mellemrum. Programmet har været evalueret med et præ- postdesign, hvori der indgik både kvalitative og kvantitative data. Af de præliminære resultater fremgår, at RTP-programmet har haft en positiv effekt på den unges evne til at opbygge en stærkere grad af robusthed og resiliens.

Af Line Spicker, master i positiv psykologi (MOPP), Hyltebjerg Skole

I løbet af de sidste år er der sket en stigning af mistrivsel blandt unge mennesker i det danske samfund. Ifølge Skolebørnsundersøgelsen (2014) fremgår det, at flere unge mennesker i Danmark har problemer med mistrivsel og har symptomer som mavepine, stress, tristhed, søvnproblemer, angst eller ensomhed. Siden Skolebørnsundersøgelsen, 2010, ses der en stigning i antallet af elever, der bl.a. oplever at være kede af det, irriterede og nervøse. Hver anden pige og hver tredje dreng har for eksempel ugentligt svært ved at falde i søvn.

Som lærer med mange års erfaring i folkeskolen oplever jeg et udtalt og voksende behov for støtte og samtaler med unge mennesker, der finder det svært at takle og håndtere de krav og forventninger, de møder fra det omgivende samfund. Krav og forventninger i forhold til uddannelse, arbejde, fri-

tidsaktiviteter, mode, sociale medier, familie og venner kan ifølge eleverne virke uoverskuelige og stressende.

De unge føler sig ikke i stand til at takle alle de krav og forventninger, de bliver præsenteret for. Ofte er det unge, der kommer fra familier og opvækstvilkår, der er præget af for eksempel omsorgssvigt, fattigdom, arbejdsløshed og misbrug. Disse unge er præget af generel mistrivsel, koncentrationsbesvær, lav følelse af self-efficacy, grænsesøgende adfærd, søvnbesvær, normbrydende – og aggressiv adfærd. De unge har ofte udfordringer med sociale relationer og kommer i konflikter med jævnaldrende og forældre. Disse konflikter ender i uoverskuelige situationer, de ikke kan løse, og hvor negative emotioner styrer følelserne. Samtidig fylder opmærksomhedsproblemer i skolen. De unge har svært ved at motivere sig selv i forbin-

delse med skolegang og fremmøde. Deres fremmøde er således meget ustabil med markant sygefravær.

Derudover afprøver, søger og eksperimenterer nogle af disse unge ligeledes med alkohol, rygning og stofmisbrug i en tidlig alder.

Hovedkonklusionerne i rapporten om børn og unges mentale helbred (Vidensraad, 2014) viser, at der er en tydelig social ulighed i forekomsten af mistrivsel, som for eksempel stress, psykiske og psykosomatiske symptomer, ensomhed og selvmord. Forekomsten af nævnte faktorer er således højest i den lave socioøkonomiske gruppe.

Hvad skal der til for at motivere de unge og få dem i en positiv udvikling?

Hvad ved vi om interventionsprogrammer og træningsprogrammer inden for området?

Den aktuelle forskning og undersøgelser viser, at interventionsprogrammer, der blandt andet træner de unges sociale færdigheder og ressourcer, øger deres self-efficacy, udvikler støttende netværk, kommunikationsevner og positiv fysisk og psykisk udvikling (Hogue, Liddle, Becker, Johnson, 2002).

Ifølge Griffin & Botvin (2010) redegør metastudier for, hvordan interventionsprogrammer i skoleregi i Nordamerika viser sig at have tydelig effekt på kort og lang sigt (seks år). De mest effektive programmer implementeres over flere år og er interaktive og fokuserede på færdighedstræning. Disse programmer viser sig signifikant effektive i at kunne reducere rygning, alkoholmisbrug, hash og andet misbrug hos unge, der deltager i programmet, sammenlignet med kontrolgruppe.

På University of Pennsylvania har en gruppe forskere udviklet programmet The Penn Resiliency Project (PRP) (Seligman, 2006), som er en gruppeintervention for børn og unge med symptomer på depression. Resultaterne af randomiserede og kontrollerede forsøg viser, at PRP forhindrer angst og depression. Samtidig viser de, at effekten er længerevarende (to år eller længere). En undersøgelse af PRPs langtids-effekt på adfærdsproblemer viser en signifikant forebyggende effekt over to til tre år på ødelæggende og destruktiv adfærd. (Cutuli, Chaplin, Gillham, Reivich, & Seligman, 2006).

Følgende afsnit er en præsentation af de metoder og teorier, som resiliens-træningsprogrammet, RTP, er forankret i.

RTPs teoretiske forankring

ABC-modellen og kognitiv adfærdsterapi.

Reivich & Shatté (2002) anvender ABC-modellen i forskellige øvelser og cases, med hvilke de bestræber sig på at fremme resiliens hos individet. En af deres hovedpointer er, at det ikke er, *hvad* vi møder af modgang og udfordringer livet igennem, men snarere *hvordan* vi møder disse udfordringer, der har betydning for og effekt på vores mentale udvikling. De sårbare unge har, ifølge Skolebørnsundersøgelsen (2014), lavt selvværd, psykosomatiske symptomer som træthed, hovedpine og søvnløshed, og de har ifølge egne udsagn svært ved at leve op til de krav og forventninger, der stilles til dem. Ifølge Seligman (2006) virker kognitiv adfærdsterapi på individet, fordi det ændrer sindstilstanden fra værende

pessimistisk til optimistisk, og ændringen kan være permanent. I relation til interventionen, RTP, inddrages kognitiv adfærdsterapi, og de unge i målgruppen arbejder med håndtering af katastrofetanker og alternative tanker igennem øvelser, der tager udgangspunkt i forskellige narrative eksempler. De unge i målgruppen udfylder derudover løbende i interventionsforløbet hver sin MTK-journal, hvori der arbejdes med modstand, tanker, konsekvens og alternative tanker. Dette er inspireret af ABC-modellen. RTP udarbejdes således, at den unge kan udvikle strategier, der kan ændre negative og uhensigtsmæssige tankemønstre og katastrofetanker, eksempelvis igen øvelserne, der omhandler det værst tænkelige scenarie, det mest realistiske scenarie og det bedst tænkelige scenarie.

Relationer og selvregulering

Hvorledes har relationer indflydelse på og betydning for individets trivsel og psykiske og fysiske velbefindende?

Forskningen viser, at tilknytning til andre mennesker og følelsen af at "høre til" har stor betydning for individets livskvalitet og trivsel, hvorimod et manglende tilhørsforhold og et svagt socialt netværk kan have negative konsekvenser for helbredet såvel fysisk som psykisk (Baumeister & Leary, 1995; Karelina & Devires, 2011).

I forbindelse med en af øvelserne i RTP skal målgruppen udfylde et sociogram, hvori de placerer deres sociale netværk og relationer, hvor der skabes mulighed for at samtale vedrørende den unges netværk.

Selvregulering handler om at kunne kontrollere følelser, tanker og opførsel (Baumeister & Vohs, 2004). Forskningen viser, at der er en væsentlig sammenhæng mellem selvregulering og relationer, og at gode relationer kan styrke graden af resiliens (Snyder et al., 2006). Evnen til selvregulering hænger sammen med psykofysiologiske processer, og der arbejdes derfor i interventionen med øvelser, hvor de unge bliver i stand til at identificere følelser som glæde, vrede, irritation og bekymring. Hvor og hvordan kan man mærke, at man er frustreret, vred, trist, glad osv.? Får man eksempelvis hjertebanken eller ondt i maven, når man er vred eller frustreret, og hvordan regulerer man bedst muligt disse følelser, når de opstår, således at man bevarer og opbygger gode sociale relationer?

Positive emotioner

Ifølge Fredrickson (2010) udvider positive emotioner tanke- og handlingsrepertoire og hjælper med at opdage nye og kreative handlinger, ideer og relationer, således at sociale og intellektuelle ressourcer opbygges. Positive emotioner kan bidrage til at håndtere udfordringer og bidrage til at restituere hurtigere efter stressende oplevelser.

Fredricksons forskning og teori (Fredrickson, 2010) beskriver, at ved at have fokus på at dyrke positivitet i sit liv, skabes der mulighed og grobund for at blomstre. At positivitet opbygger ressourcer (ukuelighed) og øger sociale ressourcer.

Ifølge Seligman (2011) bidrager positive emotioner til trivsel og positiv udvikling. Positive emotioner er det første element i hans teori om trivsel

(PERMA). Seligman pointerer, hvordan negative hændelser fylder mere end de positive, og han påpeger, hvordan denne negativitets bias giver anledning til ængstelse og depression. I denne sammenhæng beskriver han, hvordan fokus på de gode hændelser kan bidrage til at forhindre ængstelse og depression. 'Tre gode ting' – øvelsen er en øvelse, som Seligman (2011) anvender som middel til at sætte fokus på de positive hændelser i livet. 'Tre gode ting' – øvelsen inddrages således i interventionen med henblik på at fokusere på de positive hændelser i målgruppens hverdag.

Motivation og håb

Ryan & Deci (2000) dokumenterer i deres Self-Determination Theory (SDT), at mennesket har tre grundlæggende behov, der skal dækkes. Denne behovsdækning er essentiel for menneskets opblomstring. De tre grundlæggende psykologiske behov er autonomi, social forbundethed (relationer) og kompetence.

Derudover arbejder Ryan & Deci (2000) med motivation, hvor der sondres mellem indre og ydre motivation. Ved ydre styring og kontrol mindskes motivationen, hvilket kan hæmme menneskers funktion og livskvalitet. Ved indre motivation kan der skabes autonomi og selvbestemmelse og øget mulighed for opblomstring.

Således er det vigtigt at fokusere på den unges egne forventninger og håb i forbindelse med resilienstræning. Hvad vil den unge gerne have ud af resilienstræningen? Hvad er motivationen for den unge? Hvilke styrker og kompetencer kan det give den unge?

Den unge skal således deltage på baggrund af personligt engagement og interesse.

At den unge motiveres fra eventuelt at være eksternt reguleret til en indre motivation, har ifølge Ryan & Deci (2000) en afgørende betydning for den vedholdenhed, kreativitet og præstation. Ifølge Deci og Ryans (2000) SDT er kompetence ét af de tre grundlæggende behov for menneskelig opblomstring. Derfor er det vigtigt at lægge vægt på, hvilke kompetencer, et resilienstræningsprogram medfører, og derved gøre den unge bevidst om, hvilke kompetencer denne kan opnå.

Resiliens handler om at finde styrken til at overkomme modstand og udfordringer i livet. Begrebet håb som metode inddrages med henblik på at fungere som en potentiel mekanisme, hvormed resiliens kan opnås. Håb betragtes som værende en betydningsfuld faktor i en stressfuld og uoverkommelig oplevelse eller situation.

Håb handler om at kunne sætte sig et mål og at have viljen til at opnå målet. Ifølge Snyder (2000) inkluderer håb vejen til at identificere mål, men også alternative veje til at opnå disse mål. Snyder (2000) peger på, at 'high-hope' børn er sociale væsner og har en god evne til at knytte relationer. I interventionen lægges der i introduktionsfasen vægt på en afklaring af de unges egne håb og forventninger i forbindelse med RTP.

Mindfulness og MusiCure

Mindfulness betyder at være opmærksom i øjeblikket og at være ikke-dømmende. Via øvelse og træning kan individet opnå en stærkere bevidsthed om,

hvorledes de negative tanker og følelser giver hinanden næring, og hvordan man kan undgå dette (Fredrickson, 2010). Mindfulnessøvelse inddrages i RTP med henblik på at styrke de unge i deres evne til ikke at reagere følelsesmæssigt på negative tanker, så de derigennem styrker deres mentale robusthed.

Ifølge forskningsprojektet Musica Humana er MusiCure en musikintervention, der er skabt med det formål at stimulere afslappethed, velvære og velbehag. I forbindelse med anvendelse af såvel mindfulness som MusiCure i RTP, er det blandt andet hensigten, at de unge opnår en tilstand af afslappethed og velvære, så de kan skabe en mere stabil og rolig vejrtrækning og hjertefrekvens, når de føler uro, rastløshed og frustration i kroppen.

RTP case

I det følgende præsenteres en case med udgangspunkt i en ung dreng på 14 år fra en almindelig folkeskole i Københavns Kommune, der deltager i RTP. Den unge dreng henvises af sin klasse lærer. Der beskrives udvalgte dele af træningsprogrammet.

Baggrunden for henvisningen tager afsæt i, at den unge dreng er præget af generel mistrivsel, bekymrende ustabil fremmøde, koncentrationsbesvær, søvnbesvær, normbrydende og aggressiv adfærd og bekendtskab med rusmidler. Hans opvækstvilkår er præget af omsorgssvigt, fattigdom, arbejdsløshed og tidligere vold i hjemmet. Den unge dreng bor sammen med sin mor, der er kommet til Danmark flere år siden. De har begge været udsat for vold af faren og har levet på krisecenter efter trusler

på livet fra faren. Den unge dreng og hans mor lever under trange kår med økonomiske vanskeligheder og presses af fogedsager. Den unge dreng er ofte efterladt til sig selv i hjemmet og bærer et stort ansvar for sig selv i hverdagen. Klasselæreren har svært ved at få kontakt til moren. Der udarbejdes underretninger til kommunen, og der tilknyttes sagsbehandler og kontaktperson til den unge dreng. Den unge dreng har ingen familie eller tætte relationer udover sin mor. Den generelle omsorgssvigt og den alvorlige økonomiske situation, skaber i sig selv utryghed for den unge dreng og barrierer for hans positive udvikling.

Ved programmets start beskriver den unge dreng sine håb med ønsket om at lære at styre sine følelser, ikke komme i konflikter, være aggressiv og true sine jævnaldrende.

Ved gennemgang af MTK-modellen er de narrative fortællinger en stor hjælp til forståelsen af, hvad modellen går ud på. Den unge dreng identificerer og beskriver en modstand/hændelse, hvor han har været truende på de sociale medier, fordi han ikke er blevet inviteret med i biografen af sine klassekammerater. Tankerne går på, at han føler sig holdt udenfor og overset af vennerne. Han beskriver, at han føler jalousi og tristhed. Konsekvensen bliver, at han senere på dagen skriver truende beskeder på de sociale medier, der gør hans klassekammerater bange og utrygge. Han formulerer, at alternative tanker kunne være, at de ikke ville holde ham udenfor, men tog spontant af sted i biografen. Alternative tanker kunne, ifølge den unge dreng, også være at kontakte klassekammeraterne på en

stille og rolig måde og give udtryk for, at han gerne vil med næste gang.

Ved gennemgang af positive og negative emotioner og selvregulering er den unge i stand til at tegne på en tegning af kroppen, hvor hans frustrationer kommer til udtryk. Han forklarer således, at han gnider sine hænder og får lyst til at slå, når han bliver irriteret og vred. Dårlig samvittighed giver ondt i maven. Dette åbner mulighed for at samtale om, hvilke handlingsmuligheder han har. Hvis han ikke når at opdage sin vrede, så kan han måske nå at opdage, at han gnider i sine hænder. Den unge dreng foreslår således, at han kan gå fra situationen, når han mærker, at han gnider sine hænder. Dette bliver hjemmearbejde at afprøve.

Den unge dreng har søvnbesvær og har et bekymrende fravær i skolen. Ved hjælp af MusiCure er det målet, at han skal anvende MusiCure til at falde til ro om aftenen. Han skal således lytte til MusiCure 15 min. før sengetid.

Ved gennemgang af relationer og netværk anvendes et sociogram, hvori han anfører sine tætteste relationer. Dette skaber mulighed for samtale om hans venskabskreds, hvilke venner der er gode for ham, og hvem der ikke er, og hvad årsagerne til dette er. Den unge dreng bliver opmærksom på, hvem han føler, han kan stole på, og hvem der vil hjælpe ham, hvis han får behov.

Resilienstræningsprogrammet RTP

Resilienstræningsprogrammet, RTP, er således forankret i ovennævnte teori og består af syv lektioner, og hver lektion varer ca. 45 min. Lektionerne gennemføres med en uges mellemrum. På denne måde er der tid og mulighed for

den unge til at lave de planlagte hjemmøvelser/opgaver.

Resilienstræningsprogram (RTP)

1. lektion

- Etablering af relation
- Håb og forventninger til programmet
- Gennemgang af begrebet resiliens – hvad betyder det?
- Illustration af MTK-model (se model) ved hjælp af narrative fortællinger, der relaterer sig til den unges hverdag
- Den unge udfylder MTK-model med støtte fra vejleder

MTK-model:

1. **Modstand (hændelse):** Identifikation og beskrivelse af modgang/hændelse.
2. **Tanke:** Hvilke tanker gør jeg mig omkring den modgang, jeg møder.
 - **Følelser/Emotioner:** Identifikation af følelse og emotioner – bliver jeg frustreret/sur/vred/ked af det?
3. **Konsekvens:** Konsekvenserne af modgang og tanker (opførsel) Hvordan handler jeg på baggrund af mine tanker?
 - **Alternative tanker:** Hvordan kunne jeg have tænkt anderledes omkring situationen?

2. lektion

- Opsamling fra sidst – den unge udfylder ny MTK-model
- Gennemgang af betydning af positive og negative emotioner – skriv eksempler
- Håndtering af følelser (selvregulering). Den unge viser på tegning af kroppen, hvor på kroppen, den un-

ges følelser/emotioner udspiller sig. Gennemgang af illustrationen med særligt fokus på bevidsthed omkring emotionernes virkning og årsag

- 'Vær detektiv på dig selv'-øvelse (se model)
- Introduktion til 'Tre gode ting'-øvelse – hjemmeopgave

Vær detektiv på dig:

- A. Beskriv en situation, hvor dine følelser bestemte over dig og dine handlinger:
- B. Hvad var konsekvenserne af, at dine følelser bestemte over dig? Hvad skete der?
- C. Hvilke signaler sendte din krop til dig, og hvilke signaler mærkede du, da situationen opstod?

3. lektion

- Opsamling på selvregulering og Tre gode ting
 - ♦ Var du i stand til at mærke dine egne følelser?
 - ♦ Nåede du at reagere på din krops signaler, inden du handlede på følelserne?
 - ♦ Hvad var din strategi?
- Introduktion til MusiCure
 - ♦ Beskrivelse af MusiCure. Finde numre og aftale hjemmeøvelser
- Introduktion til Mindfulness
 - ♦ Beskrivelse af mindfulnessøvelse. Praktisere øvelsen og aftale hjemmeøvelser

4. lektion

- Opsamling på MusiCure og Mindfulness
- Introduktion til katastrofetanker og tankefælder (se model)
- Udfylde MTK-skema og Håndtering af katastrofetanker-skema

Katastrofetanker-skema:

Se nedenstående skema

5. lektion

- Opsamling på katastrofetanker, MusiCure, Mindfulness og Tre gode ting-øvelser
- Relationer og netværk
 - ♦ Identifikation af netværk ved hjælp af sociogram. Samtale om betydning af netværk og rollemødder

6. lektion

- Opsamling på betydning af relationer og netværk
- Opsamling på MusiCure, Mindfulness og Tre gode ting-øvelser
- Udfylde MTK-model og katastrofetanker

7. lektion

- Evaluering
- Gennemgang af håb og forventninger fra 1. lektion
- Evaluering af strategierne
- Hvad fungerede godt?

**Værst tænkelig
scenarie**

**Mest realistiske
scenarie**

**Bedst tænkelige
scenarie**

- Hvad kunne have været bedre eller hvad kunne ændres?

Virker RTP?

RTP har blandt andet været evalueret med Achenbachs Emipiribaserede Assessmentsystem ASEBA (Achenbach, 2009), som består af forskellige spørgeskemaer, der er udviklet til at udrede forskellige kompetencer og problemfelter hos børn, unge og voksne. ASEBA-systemet giver mulighed for at differentiere psykopatologiske mønstre hos børn og unge, hvor de kan have mere eller mindre af et specifikt karaktertræk (Achenbach, 2009).

Spørgeskemaerne er udformet med danske normer, således at resultaterne af spørgeskemaerne kan sige noget om, hvordan den unge er sammenlignet med andre unge i almindelighed i Danmark (Nissen, 2011).

Det kan være en fordel at lave en præ-test og en post-test, således at det er muligt at skabe sig et indtryk af, om der har været en udvikling hos den unge, der giver sig til udtryk i ASEBA målingerne.

Med udgangspunkt i den beskrevne case evalueres RTP med ASEBA og et semistruktureret interview.

Præ-test ASEBA målingerne viser en tendens til, at lærerne, i højere grad end den unge selv og hans mor, indplacerer ham på et niveau, hvor vanskelighedernes mængde er bekymrende. Den unge og hans mor indplacerer ham således inden for normalområdet.

Præ-testen, der er lavet af lærerne, viser, at den unge dreng, ligger inden for det normale område, hvad angår *angst/deprimeret, indelukket/deprimeret og fysiske klager*. Han indplaceres i

et grænseområde inden for *sociale problemer* og *opmærksomhedsproblemer*. Den unge dreng indplaceres i "klinisk niveau", svarende til at færre end to procent af drenge på hans alder har tilsvarende vanskeligheder i *normbrydende adfærd* og *aggressiv adfærd*.

Post-test ASEBA målingerne viser, at lærerne indplacerer den unge dreng inden for normalområdet, hvad angår *angst/deprimeret, indelukket/deprimeret, fysiske klager* og *sociale problemer*. Han har bevæget sig fra grænseområdet til det normale til et niveau, der skønnes at være normalt for alderen i *sociale problemer*. I *normbrydende adfærd* ses der en forbedring hos den unge, idet han har bevæget sig fra "klinisk niveau" til grænseområdet til det normale. Den største udvikling hos den unge dreng er inden for *aggressiv adfærd*, hvor han har bevæget sig fra "klinisk niveau" til normalområdet.

ASEBA målingerne stemmer således meget overens med den unge drengs opfattelse af sin egen positive udvikling, hvilket den unge dreng tillagde stor betydning.

Under det semistrukturerede interview, giver den unge dreng udtryk for, at han er blevet bedre til at styre og kontrollere sine følelser og reaktioner. Igennem de to måneder forløbet tog, har han således ikke været truende, voldsom eller været i konflikt. Han føler, at han har lært nogle strategier, som han kan bruge i situationer, hvor han før blev aggressiv. Den unge dreng giver udtryk for, at han er blevet mindre stresset, fordi han kan falde i søvn til MusiCure og dermed får mere søvn. Derudover føler han, at han har fået en bedre kontakt til lærerne på skolen.

Diskussion og konklusion

En udfordring i programmet ligger i, at RTP ikke inddrager familie eller andre primære personer i programmet. RTP arbejder således isoleret med den unge dreng, imens hjemmeforholdene bidrager til at fastholde den unge drengs problemer. Dette kan give en bekymring for, hvor lang tid effekten af programmet vil være. Derfor vil det være relevant at udvikle et RTP program, der ikke udelukkende inddrager den unge, men også forældre eller andre primære personer. Dette kan skabe mulighed for at udvikle forældrekompetencer og nedbryde barriererne for den positive udvikling.

En anden udfordring i programmet knytter sig specifikt til en øget selvbevidsthed og selvindsigt opnået under RTP, hvilket ikke kun viser sig som en positiv udviklingsstrategi, men også en ulempe. Med den øgede selvbevidsthed og selvindsigt opstår en sårbarhed, der kan resultere i en ødelæggende selvkritik. Der påhviler her et stort ansvar i forbindelse med at passe på den unges integritet og grænser. Det er vigtigt, at selvbevidstheden og selvindsigten skaber mulighed for en positiv udvikling, hvor kompetencer, håb, positive emotioner og relationer indgår konstruktivt.

I RTP forløbet er der planlagte hjemmeopgaver mellem lektionerne. Der skal for eksempel skrives *Tre gode ting*, høres MusiCure og laves mindfulnessøvelser. Det viser sig at være udfordring for den unge dreng. Han får sjældent lavet sine øvelser, og der er ikke ressourcer til opbakning i hjemmet til at få dem lavet. Dette peger på, at de planlagte hjemmeopgaver kan være en udfordring i programmet.

Som en del af det indledende i interventionen skal den unge forsøge at beskrive sine egne håb og forventninger til RTP. Forudsætningen for dette er et ønske om forbedring, selvindsigt og forandring. Dette fordrer håb, mod og energi. Hvis dette mobiliseres, kan håb og forventninger så efterfølgende indfries? Er de urealistiske? Bliver RTP løsningen på alle problemer og udfordringer? RTP bør således ikke fremstilles som en mirakelkur, der fjerner alle problemer natten over, men derimod som et redskab, der kræver længerevarende arbejde fra den unges side. En begrænsning i RTP ligger i, at programmet afsluttes efter syv lektioner, hvorefter den unge ikke har primære relationer, der kan støtte op om de ny erhvervede strategier og færdigheder. Det vil derfor være relevant at lærere og eller pædagoger, der arbejder med unge i mistrivsel, har indsigt i RTP, således at de kan anvende og inddrage for eksempel MTK-modellen i hverdagen i deres samtaler med den unge.

Evaluerings af programmet ved anvendelse af blandt andet ASEBA og semistrukturerede interviews peger på, at RTP har positiv effekt på den unge drengs evne til at opbygge en stærkere grad af mental robusthed og resiliens. ASEBA undersøgelserne viser, at der er en generel fremgang i kompetencer og problemfelter. Det semistrukturerede interview peger på blomstrende håb og optimisme hos den unge. Den unge dreng udtrykker således glæde ved at have fået færdigheder og alternative handlemuligheder og dermed strategier til at komme ud af uhensigtsmæssig adfærd.

Evaluering af programmet peger på, at strategierne, som for eksempel MTK modellen, og relationen til vejlederen, har betydning for effekten af programmet. Kvaliteten af undervisningen ligger således i relationen til den unge og vejlederens evne til at varetage den unges integritet og sårbarhed under forløbet.

Referencer

- Achenbach, T.M. (2009) The Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA): Development, Findings, Theory, and Applications, Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth & Families
- Baumeister, R.F. & Leary, M. R. (1995) The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation. *Psychological Bulletin*, 117(3):497-529.
- Baumeister, R. F., & Vohs, K. D. (Eds.) (2004). *Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications*. New York: Guilford.
- Cutuli, J.J., Chaplin, T.M., Gillham, J.E., Reivich, K.J., & Seligman, M.E.P. (2006). Preventing co-occurring depression symptoms in adolescents with conduct problems: The Penn Resiliency Program. New York Academy of Sciences, 1094, 282-286
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. In *American Psychologist*. American Psychological Association 2000.
- Fredrickson, B. L. (2010). *Posiviteten Kilder til vækst i livet*. København: Dansk Psykologisk Forlag.
- Griffin, K. W., & Botvin, G. J. (2010). Evidence-Based Interventions for Preventing Substance Use Disorders in Adolescents. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 19(3), 505-526
- Hogue A, Liddle HA, Becker D, Johnson-Leckrone J. 2002. Family-based prevention counseling for high-risk young adolescents: immediate outcomes. *J. Community Psychol.* 30:1-22
- Karelina, K. & DeVries, A.C.(2011) Modeling Social Influences on Human Health. *Psychosomatic Medicine*, 73(1):67-74
- Nissen, P. (2011) *Achenbachs Child Behavior Checklist CBCL og relaterede instrumenter*. Forlaget Skolepsykologi
- Reivich, K. & Shatté, P. (2002). *The Resilience Factor* (s. 30-185). New York: Broadway Books
- Seligman, E.P.M. (2006). *Learned Optimism*. New York: Vintage Books
- Seligman, M. (2011). *At lykkes En perspektivrig positiv psykologi om lykke og trivsel*. København: Forlaget Mindspace
- Snyder, C. R. (2000). *Handbook of Hope. Theory, Measures & Applications*. California: Academic Press
- Snyder, D. K., Simpson, J., & Hughes, J. (Eds.) (2006) *Emotion regulation in couples and families: Pathways to dysfunction and health*. Washington, DC: American Psychological Association.

Netbaserede kilder:

- Skolebørnsundersøgelsen (2010) www.hbsc.dk/downcount/HBSC-Rapport-2010.pdf
- Skolebørnsundersøgelsen (2014) <http://www.hbsc.dk/downcount/HBSC-Rapport-2014.pdf>
- Vidensråd (2014) www.vidensraad.dk/sites/default/files/fakta_om_boern_og_unge_mentale_helbred.pdf